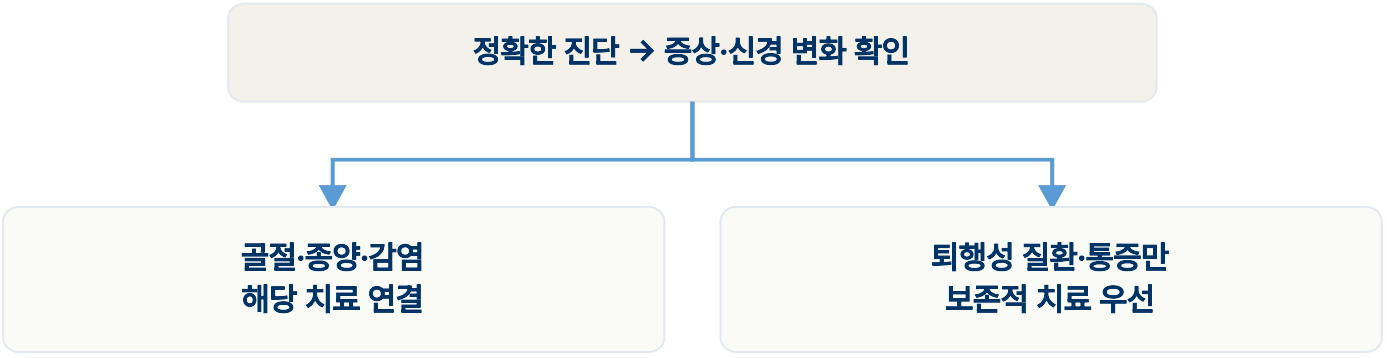
요통 · 통증 양상과 신경학적 변화부터

영상보다 병력 · 야간통·휴식기 극심한 통증은 감염·종양 감별



첫 문진 체크리스트

부위·정도·발생 시기·악화/완화 요인, 통증 표현, 치료 반응, 환자의 요구, 암·대상포진 병력을 묻습니다. 대개 요통은 쉬면 완화되므로 휴식해도 완화되지 않는 통증은 감염·종양을 생각합니다.

놓치지 말아야 할 소견

구분	진료 중 확인할 내용
전이성 척추 종양	악성종양 병력, 진행성 통증·마비, 야간·휴식기 심한 통증. X-ray의 pedicle shadow 소실(winking owl sign), 골용해성 음영. 암 병력이 없어도 고령의 비전형적 지속 통증에서 의심.
척추 감염	화농성·결핵성 척추염. 초기에 모호한 증상으로 종양·Modic change·골절과 구별이 어려울 수 있어 감별에 포함.
골절·종양·감염	먼저 정확히 진단하고 해당 치료로 연결.

하지 방사통 뒤 새 위약 · 본강 증례

31세 여성은 내원 2일 전 하지 방사통, 하루 전부터 발목 위약이 생겨 수술 치료를 받았습니다. 통증만 있으면 보존적 치료를 우선하지만 힘이 떨어지거나 마비가 진행하면 수술 평가를 계획한다고 설명했습니다. SLR은 30~60°의 양성 소견이 진단에 도움이 됩니다.

척추 전문 진료로 연결할 때

보존적 치료 실패·극심한 통증·신경학적 증상 · 영상만으로 수술 결정 금지

기본 영상에서 확인

구분	진료 중 확인할 내용
X-ray	AP·lateral 기본, 필요시 flexion·extension 동적 촬영. 서서 척추 배열·불안정성을 볼 수 있고 추적이 용이.
볼 항목	척추 배열, 전방전위·불안정성, 추간 간격·추간공 협착 가능성, 척추경 소실. 필요시 MRI·CT 등 추가 검사.

수술 평가를 고려할 상황 · 본강

보존적 치료 실패, 극심한 통증·큰 일상 지장, 마비 등 신경학적 증상 발생 시 전문 평가를 연결합니다. 탈출증·협착증에 동반된 심한 엉치·다리 통증이나 파행, 심한 척추 변형 통증이 수술 대상이 될 수 있습니다. 요통만으로 수술하는 경우는 드물고, 방사선 소견만으로 결정하지 않습니다.

조재환 연자 Q&A · 장기간 협착증

몇 년간 크게 나빠지지 않고 유지되면 보존적 치료와 관찰이 가능하다고 답했습니다. 갑작스러운 마비는 흔하지 않으나, 신경 증상이 서서히 악화되면 수술 뒤에도 만성 신경병성 통증·위약이 남을 수 있습니다. 보행거리가 계속 짧아지거나 감각저하·힘 빠짐이 진행하면 척추 전문 진료가 필요하다고 설명했습니다.

관찰 중 치료와 재평가

구분	진료 중 확인할 내용
보존적 치료 · 본강	약물·물리·운동·주사 치료가 기본. 급성 침해성 통증은 NSAID, 신경병성 성분은 gabapentin/pregabalin. NSAID는 심혈관·위장관·신장 위험과 연령 고려. 만성 요통은 운동 필수.
걷기 · 연자 Q&A	100~200 m 보행 후 쉬는 증례에서도 걷기를 적극 권유. 꾸준한 운동이 보행 능력과 보존적 치료 반응에 도움 된다는 경험을 설명.

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/clinical/asl28-179-back-pain-referral/